EDUCACIÓN MATERNAL

Guía básica de posparto y lactancia

Mª Isabel Carreras · Matrona



Contenidos

El posparto

PARTE 1

- Qué es y qué esperar
- Cambios físicos normales
- Cambios emocionales
- Contacto piel con piel

Lactancia

PARTE 2

- Lactancia materna
- Cómo saber si mama bien
- Problemas frecuentes
- Extracción y almacenamiento

El recién nacido

PARTE 3

- Cuidados del recién nacido
- El llanto y el cólico
- Sueño seguro del bebé

PARTE 1

El posparto

Los primeros días y semanas después del parto

CONCEPTO

El posparto: qué es y qué puedes esperar

> El posparto es un proceso fisiológico de recuperación y adaptación que va desde el parto hasta que el cuerpo vuelve progresivamente a su estado previo (normalmente 6–8 semanas).

Fases

Posparto inmediato

0–24 H

- El útero empieza a contraerse (entuertos).
- Se controla el sangrado y constantes.
- Se inicia piel con piel y lactancia.
- Sensaciones habituales: cansancio, alivio, euforia.

Posparto precoz

2.º–7.º DÍA

- Subida de la leche (48–72 h).
- Loquios cambian de rojos a más claros.
- Aparece el maternity blues.
- Mayor riesgo de congestión mamaria y grietas.

Posparto tardío

2.ª–6.ª SEMANA

- El útero termina de volver a su tamaño.
- Cicatrizan heridas.
- Se empieza a recuperar la rutina.
- Ajuste emocional al nuevo rol.

TU CUERPO

Cambios físicos normales

Útero

- Se contrae progresivamente → entuertos.
- Recupera tamaño en unas 6 semanas.

Sangrado (loquios)

- Rojo → marrón → amarillento/blanco.

Mamas

- Cambian de tamaño y función.
- Calostro → leche madura.
- A las 48–72 h suele aparecer ingurgitación.

Sangrado: acude si...

- Hay olor fétido
- Tienes fiebre
- Aumenta el sangrado o salen coágulos grandes

TU ÁNIMO

Cambios emocionales

Maternity blues

MUY FRECUENTE

- Aparece días 3–7.
- Llanto fácil, irritabilidad, sensibilidad.
- Desaparece solo en 1–2 semanas.

Depresión posparto

NECESITA AYUDA

- Más intensa y duradera.
- Tristeza persistente, ansiedad, culpa.
- Necesita ayuda profesional.

Psicosis posparto

URGENCIA MÉDICA

- Rara pero grave.
- Delirios, desorientación, riesgo.
- Es una urgencia médica.

DESDE EL NACIMIENTO

Contacto piel con piel (CPP)

> Se recomienda desde el nacimiento y al menos 1–2 horas seguidas.

Beneficios

- Regula temperatura, glucosa y respiración.
- Disminuye el llanto.
- Facilita la lactancia.
- Mejora el vínculo.
- Transfiere microbiota materna al bebé.

Cómo hacerlo

- Bebé desnudo sobre el pecho desnudo.
- Cubierto con manta y gorrito.
- Cabeza girada de lado.
- No usar móvil.
- Vigilar color y tono del bebé.

PARTE 2

Lactancia

Materna, práctica y con apoyo

RECOMENDACIÓN OMS

Lactancia materna

> La OMS recomienda lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y continuar con alimentación complementaria hasta 2 años o más.

Tipos de leche

TIPO	CUÁNDO	CARACTERÍSTICAS
Calostro	Primeros días	Espeso, amarillo, 2–20 ml
Transición	4.º–15.º día	Más volumen y más calorías
Madura	Desde 2.ª semana	Leche acuosa al inicio y más grasa al final

POSICIÓN, AGARRE Y SUCCIÓN

Cómo saber si el bebé mama bien

Posición

- Cabeza y cuerpo alineados.
- Bien pegados.
- Cara mirando al pecho.

Agarre correcto

- Boca muy abierta.
- Labios hacia fuera.
- Mentón tocando el pecho.
- Entra pezón y areola (no solo el pezón).

Succión eficaz

- Ritmo lento con pausas.
- Se oye tragar.
- Mejillas redondas.

CÓMO RESOLVERLOS

Problemas frecuentes

Grietas

- Suelen deberse a mal agarre.
- Dejar pezón al aire, lanolina, aceite de oliva, una gotita de leche materna.
- Si están abiertas: Cristalmina.

Crisis de lactancia

- 3 semanas, 6 semanas, 3 meses, 1 año, 2 años.
- Son fases de ajuste producción–demanda.

Mastitis

CÓMO RECONOCERLA

- Pecho rojo, caliente, dolor, fiebre.

Tratamiento inicial

- Dar pecho o sacar leche.
- Antiinflamatorios.
- Masaje y calor previo.
- Frío después.

Si no mejora en 24 h

Antibiótico (consultar al médico). Valorar posterior probiótico para evitar nuevos episodios.

CUANDO NO ESTÁS CON EL BEBÉ

Extracción y almacenamiento de leche materna

La extracción de leche permite mantener la lactancia cuando la madre no está con el bebé (trabajo, estudios, hospitalización…) o para aliviar el pecho.

¿Cómo se puede extraer?

- Manual.
- Sacaleches (eléctrico o manual).

Es importante

- Lavarse las manos.
- Usar recipientes limpios.
- Estar en un entorno tranquilo.
- Estimular el pecho (masaje o calor suave antes).

¿Cómo descongelar y calentar?

- Descongelar en la nevera o bajo agua templada.
- No usar microondas.
- Calentar al baño maría o con agua caliente.
- Agitar suavemente para mezclar la grasa.

Una vez descongelada

- Usar en 24 h si está en nevera.
- No volver a congelar.

¿Cómo conservar la leche materna?

Ambiente

TEMPERATURA AMBIENTE

Hasta 4 horas

Nevera

DE 0 A 4 ºC

Hasta 5 días

Congelador

-18 ºC

Hasta 6 meses

Guarda la leche en pequeñas cantidades (60–120 ml) y pon siempre fecha y hora.

PARTE 3

El recién nacido

Cuidados, llanto y sueño seguro

LOS PRIMEROS DÍAS

Cuidados del recién nacido

Peso y aspecto

- Pierden hasta 10 % los primeros días.
- Recuperan entre el día 5–10.

Cordón umbilical

- Lavar con agua y jabón.
- Secar bien.
- Se cae en 7–15 días.

Consultar si

- Huele mal.
- Está rojo o supura.
- Sangra mucho.
- No cae tras 15 días.

Baño

- Ambiente cálido.
- Agua templada.
- pH neutro.
- Nunca dejar al bebé solo.

Dormir

- Boca arriba.
- Sin objetos en la cuna.
- Dormir en la misma habitación.

ENTENDER A TU BEBÉ

El llanto y el cólico

> El llanto es comunicación. Consultar si es inconsolable o diferente a lo habitual.

Cólico del lactante

- Menor de 4 meses.
- Más de 3 h/día, más de 3 días/semana, más de 3 semanas.
- Llanto intenso por la tarde-noche.
- Desaparece solo.

Medidas

- Porteo.
- Masajes.
- Eructar.
- Probióticos.
- Posiciones antiálgicas.

REDUCIR EL RIESGO DE MUERTE SÚBITA

Sueño seguro del bebé

> Dormir es una parte fundamental del desarrollo del recién nacido. Sin embargo, es importante crear un entorno de sueño seguro para reducir el riesgo de muerte súbita del lactante (SMSL) y otros accidentes.

¿Cómo debe dormir el bebé?

✓ Siempre boca arriba

Es la posición más segura para dormir, tanto de día como de noche. Dormir boca abajo o de lado aumenta el riesgo de SMSL.

✓ Superficie firme

Colchón duro, plano y ajustado a la cuna o minicuna.

No deben usarse sofás, sillones, cojines ni superficies blandas para dormir.

✓ Misma habitación

En la misma habitación que los padres, durante al menos los primeros 6 meses.

Esto facilita la lactancia y reduce el riesgo de SMSL.

¿Qué NO debe haber en la cuna?

En la cuna solo debe estar el bebé.

✕ Almohadas

✕ Peluches

✕ Mantas sueltas

Para abrigarlo: mejor saco de dormir o pijama adecuado.

Temperatura y ambiente

- Habitación fresca y ventilada (ideal: 20–22 ºC).
- Evitar exceso de ropa o calor.
- No cubrir nunca la cabeza del bebé al dormir.

Lactancia y sueño seguro

- La lactancia materna protege frente al SMSL.
- El contacto piel con piel y el dormir en la misma habitación favorecen tanto la lactancia como el descanso.